

07

우수검사실 신임인증 심사점검표

종합검증

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2026. 01

2026 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

종합검증

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
-	

• 수정

문항번호	수정유형
07.010.020	설명 수정
07.010.090	설명 수정
07.300.121	문항분류체계 수정
07.300.420	문항분류체계 수정

• 삭제

문항번호	사유
-	

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

종합검증

1	심사범위	5
2	질관리: 일반	6
	1. 질관리 일반	6
3	질관리: 검사단계	7
	1. 정도관리 일반	7
	2. 정도관리지침	8
4	질관리: 검사전후단계	9
	1. 검사결과 보고	9
5	검사수행 및 장비 운용	11
	1. 임상정보	11
6	인력	12
	1. 전문의	12

종합검증

1 심사범위

문항	핵심C 07.010.020 검사실에서 시행하는 모든 검사 분야에 대해 인증 심사를 받는가?	예 (필수)		아니오	
설명	• 별도의 검사실을 포함하여, 인증 심사일을 기준으로 검사실에서 시행하는 모든 검사목록을 제시하여야 한다. 검사목록에 검사실자체개발검사(LDT)여부가 표시되어야 한다. • 목록에 있는 검사의 해당 분야가 빠짐없이 신청되었는지를 확인한다. • 심사팀장은 모든 검사목록이 심사에서 누락되지 않도록 심사분야를 확인하고 심사원을 배정하여야 한다. • 검사 분야에 대한 해석은 대한진단검사의학회의 유권해석에 따른다. • 인증 심사일 이후에 인증 분야 외의 검사를 신규 개설하는 경우에는 해당 분야의 추가 인증 신청을 원칙으로 한다. • 그람염색, 신종인플루엔자 검사 등 한 분야에 한 가지 검사만 시행하더라도 해당 분야의 심사를 신청하여야 한다. • 검사실에서 시행하는 검사의 해당 분야 중에 한 분야라도 인증심사를 받지 않는 경우, '아니오'로 평가한다. • 우수검사실신임인증 결과는 공개적으로 게시하고 경영진 및 관련 직원들과 공유한다. • '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	핵심C 07.010.040 주 검사실과 분리된 별도의 검사실을 가진 경우도 각 세부분야별로 심사가 진행되는가?	예 (필수)		아니오	
설명	• 진단검사의학과 산하의 응급검사실, 부검검사실, 별도의 센터 검사실 등이 이에 해당한다. • 별도의 검사실에서 시행하는 모든 검사목록을 제시하고, 해당 세부분야 심사에서 심사받아야 한다. • 심사팀장은 각 세부 분야 심사원들에게 상기 검사목록을 인지시키고, 심사에 포함되어야 한다. • 주 검사실과 분리된 별도의 검사실이 없는 경우에는 '예'로 평가한다. • '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 07.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)	아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • 지난번 심사(직전 현장심사와 자체심사 모두 포함)에서 감점 사항이 없을 경우 '해당없음'으로 평가한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.					

2 질관리: 일반

1. 질관리 일반

문항	기본B 07.201.020 검사실은 지속적 질향상 프로그램(continuous quality improvement program, CQI)이 있는가?	배점 (16)		아니오	
설명	• 검사실은 정의된 목표에 맞는 질향상 활동 주제를 선정하고, 목표를 달성하기 위한 구체적인 수행 방법이 있어야 한다. • 질향상 활동은 정기적인 업데이트 및 지속적인 관리를 한다. • 질향상 프로그램 계획 및 결과는 검사실이 속한 기관에 보고되어야 하고, 경영진 및 관련 직원들과 공유한다. • 진단검사의학과내 CQI를 가지고 있는지 CQI 조직도, 규정, 회의록 등을 통하여 확인하고, CQI 조직도 내에서 진단검사의학과 전문의가 주도적 역할을 수행하고, 1년간 지속하여 보고서를 작성한 경우 만점을 부여한다. • CQI를 구성은 하였으나 1년간 지속하지 못하였거나, 회의록이 미비하거나, 진행상황에 대한 첨부자료의 실적이 미비한 경우 '8점'을 감점하고, QC 등의 부적당한 자료를 제시하는 경우는 '0점'으로 평가한다. • 진단검사의학과내 CQI 프로그램이 해당 기관의 연간 CQI 활동의 일환이어야 한다.				

문항	기본B 07.201.080 종합검증판독의 사무적 오류를 점검하는 시스템이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 없음				

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 07.300.020 대한진단검사정도관리협회 등에 회원으로 가입하여 외부정도관리 프로그램에 참여하고 있는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 국내 및 국외 외부정도관리 프로그램에 참여하여 1년간의 실적이 있는 경우 만점을 부여하고, 참여는 하나 1년간의 실적이 미비한 경우 4점을 감점한다(신규기관인 경우, 대한진단검사정도관리협회에 가입되어 있으면, 만점을 부여한다.). - 해당 분야별로 전년도 외부정도관리 사업 참여 현황이 기록된 목록을 확인한다. - 대한진단검사정도관리협회 참가증과 검사실의 검사 분야를 대조하여 현재 검사실에서 실시하고 있는 모든 분야에 참가여부를 확인한다. - 외부정도관리 프로그램 결과를 공개적으로 게시하고 경영진 및 관련 직원들과 공유한다.				

문항	필요R 07.300.121 검사실은 정확한 검사를 위하여 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																																	
설명	• 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. • 외부정도관리 결과가 정해놓은 기준을 벗어나는 경우, 검사실은 시정 조치를 실시, 기록하고, 시정 조치의 효과를 모니터링해야 한다. 외부정도관리 결과의 경향을 평가하여 기준을 벗어날 가능성이 높을 경우 예방 조치를 취해야 한다. 외부정도관리 결과의 분석 과정에 관련 직원을 참여시켜야 한다. • 검사실운영 분야는 외부정도관리 체계 전반에 대하여 평가한다. 외부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다. • 검사실운영 외 5개 분야의 점수는 해당 분야의 300.120 문항의 점수를 기입한다. 그 다음 각 분야의 감점 점수를 기입한다. 이 문항의 최종 점수는 배점(16점)에서 6개 분야 감점점수의 총합을 감점하여 산출한다.																																						
	<table><tr><th>분야</th><th>배점</th><th>분야점수</th><th>감점점수</th></tr><tr><td>검사실운영</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단혈액</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상화학</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상미생물</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>수혈의학</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단면역</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>최종점수</td><td>16</td><td></td><td></td></tr></table>							분야	배점	분야점수	감점점수	검사실운영	16			진단혈액	16			임상화학	16			임상미생물	16			수혈의학	16			진단면역	16			최종점수	16		
	분야	배점	분야점수	감점점수																																			
	검사실운영	16																																					
	진단혈액	16																																					
	임상화학	16																																					
	임상미생물	16																																					
	수혈의학	16																																					
	진단면역	16																																					
	최종점수	16																																					
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																							

문항	필요R 07.300.420 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																
설명	- 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 검사실운영 분야의 점수는 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대하여 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다. - 검사실운영 외 5개 분야의 점수는 해당 분야의 301.211 문항의 점수를 기입한다. 그 다음 각 분야의 감점점수를 기입한다. 이 문항의 최종점수는 배점(24점)에서 6개 분야 감점점수의 총합을 감점하여 산출한다.																																			
	<table><tr><th>분야</th><th>배점</th><th>분야점수</th><th>감점점수</th></tr><tr><td>검사실운영</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단혈액</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상화학</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상미생물</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>수혈의학</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단면역</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>최종점수</td><td>24</td><td></td><td></td></tr></table>				분야	배점	분야점수	감점점수	검사실운영	24			진단혈액	24			임상화학	24			임상미생물	24			수혈의학	24			진단면역	24			최종점수	24		
	분야	배점	분야점수	감점점수																																
	검사실운영	24																																		
	진단혈액	24																																		
	임상화학	24																																		
	임상미생물	24																																		
	수혈의학	24																																		
	진단면역	24																																		
	최종점수	24																																		
‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																				

2. 정도관리지침

문항	기본B 07.301.320 내부정도관리 기록을 담당 임상병리사는 매일, 책임 임상병리사는 매주, 진단검사의학과 전문의는 매월 점검하고 있으며 그 기록을 보관하고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 지침서와 내부정도관리 기록을 확인한다. - 내부정도관리 기록 상 문제가 있는데도 적절한 조치를 취하지 않은 경우에는 매일 평가하지 않는 것으로 보아 '0점'으로 평가한다. - 매주나 매월 단위로 평가된 경우, '2점'을 감점한다.				

문항	기본B 07.301.500 내부정도관리 기록은 적어도 2년간 보관하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 개원한지 2년이 되지 않은 경우에는 개원 당시부터 현재까지의 기록이 보관되는지를 확인한다. - 초기심사 시에는 지침서의 보관 규정을 확인하고, 시행 의지가 있는지 확인한다. - 본 심사 시 지침서의 보관 규정을 확인하고, 최소한 초기 심사 이후의 기록이 보관되어 있는지 확인한다.				

4 질관리: 검사전후단계

1. 검사결과 보고

문항	기본B 07.405.420 종합검증보고서를 진단검사의학과 전문의가 직접 작성하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 진단검사의학과 전문의가 직접 시행하여야 하며, 여러 명의 전문의가 있는 기관의 경우 전문의 1인당 1일 20명을 초과하여서는 안된다. 예를 들어 2명의 전문의가 있는 기관에서 1명의 전문의만 계속 1일 21~40명에 대한 보고서를 낸다든지, 하루씩 번갈아 21~40명에 대한 보고서를 내는 경우 '0점'으로 평가한다. 전공의가 있는 병원의 경우에는 교육 목적상 전공의가 1차 작성을 하고 전문의가 최종 확인하고 교정해 주는 것은 가능하나, 최종 확인 및 교정 과정을 성실히 시행하지 않는다고 판단되면 '0점'으로 평가한다. 또한 과내 한 전문의가 다른 전문의에게 보고서 작성 및 보고를 맡겨서 1일 20명 제한 조건을 어기는 경우 '0점'으로 평가한다. - 처음 심사를 받는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 07.405.500 최종 결과보고서에는 아래 사항이 기재되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 아래 사항이 기재되어야 한다. - 검사명, 결과, 단위(SI unit 등) - 환자 성명, 성별, 나이(생년월일), 병록번호 - 의뢰의사명 - 검체명, 채취일시, 채취부위(필요시) - 접수일시, 검사일시, 결과 보고일시 - 검사자, 보고자 - 전문 의 검토 및 서명(전문 의가 판독하고 판독소견서를 작성해야 하는 검사의 경우) - 검사실명 및 연락처 - 위탁검사 여부 - 참고구간, 임상 결정 값(clinical decision value), 임상 결정 값을 뒷받침하는 도표/계산도표(normogram) (필요한 경우) - 결과의 해석(필요한 경우) - 주의 또는 설명 메모(예: 결과에 영향을 주는 검체의 질/적합성, 위탁 검사실의 결과/해석, 개발 과정의 사용) (필요한 경우) - 페이지 수/총 페이지 수(예: '페이지 1/1', '페이지 2/5' 등) "본 검사실은 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 우수검사실 신임 인증을 받은 검사실입니다." 라는 내용이 결과지에 들어가는 것을 권장한다. - 수탁의료기관의 경우, 검사실명과 주소가 반드시 있어야 한다. 검사실명과 주소가 없는 경우 '0점'으로 평가한다. - 종합검증보고서에는 환자의 인적사항, 의뢰과 혹은 의뢰의사, 종합검증 대상 검사, 비정상 검사 결과치, 검사 결과에 관한 전문 의의 검증/판독결과, 보고일자과 보고 전문 의의 서명, 대한진단검사의학회의 인증마크가 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 07.405.701 종합검증 보고서의 사본이나 검사 정보시스템에 보고서가 보관되어 필요시에 언제나 조회할 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 처음 심사를 받는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 07.405.806 종합검증 판독 보고서를 성실히 작성하여 그 내용이 만족할 만한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 종합검증 판독 보고서 사본철을 심사하여 그 내용이 성실히 작성되고 환자의 진단 및 치료에 도움을 줄 수 있는 내용으로 만족할 만한지 평가한다. • 처음 심사를 받는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 07.405.807 종합검증 판독 보고서가 환자의 치료에 도움을 줄 수 있는 시기에 보고되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 환자가 퇴원할 때나 퇴원 후 보고되는 경우는 '0점'으로 평가한다. • 처음 심사를 받는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

5 검사수행 및 장비 운용

1. 임상정보

문항	기본B 07.601.071 검사정보시스템이나 수기법으로 종합검증 환자수 제한, 입원기간 중 1회 산정 (보고) 등 조건을 지킬 수 있는 시스템이 있으며 이의 결과가 기록보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 없음				

문항	기본B 07.601.072 병원정보시스템이나 환자의 의무기록 조회 등에 의한 환자의 임상정보를 조회할 수 있는 시스템이 구축되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 없음				

6 인력

1. 전문의

문항	기본B 07.702.041 진단검사의학과 전문의는 종합검증에서 필요로 하는 모든 검사체제 및 검사과정을 관장하며 검사결과의 정확성과 신빙성을 책임질 수 있는 권한을 위임 받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 없음				

문항	기본B 07.702.220 진단검사의학과에 검사 업무량에 적절한 수의 진단검사의학과 전문의가 상근하고 있는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 점수는 제출하신 전문의 수에 근거하여 자동 배점됩니다. - 검사실 전년도 검사수 : __건 / 상근 진단검사의학과 전문의 수 __명 - 검사실에서 검사실 전년도 검사수의 변경을 원할 경우에는 소명자료에 의하여 심사를 통하여 전년도 검사수를 조정할 수 있다. - 이때 심사기준은 다음과 같다. (1) 검사건수 집계기준은 의료보험에 등재된 검사분류를 원칙으로 한다(예: CBC: 8건, ABGA: 1건, Urinalysis: 1건). (2) 청구되지 않는 검사는 건수에서 제외한다(예: 계산된 LDL, A/G ratio 등). (3) 건강검진 검사건수, 비급여 검사 등은 검사건수에 포함된다. (4) 외부로 검사의뢰를 한 검사는 제외하고, 검사의뢰를 받아 수행한 검사는 포함한다. - 상근 진단검사의학과 전문의 수 __명				

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 종합검증분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신 모든
사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2026년 ____월 ____일